

TEMA 3.4 • OBSTETRICIA

Hiperemesis Gravídica

PERFIL EUNACOM 2.01.2.013
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hiperemesis Gravídica

Causa

Gonadotropina coriónica humana (HCG) — principal. Los estrógenos también participan, pero la HCG es lo más importante.

Ocurre en la **primera mitad del embarazo** (peak en semanas 8–12, cuando la HCG es máxima).

NOTA CLÍNICA

Es normal que toda embarazada tenga algún grado de náuseas. La hiperemesis gravídica se distingue por la **severidad** de los síntomas.

Diagnóstico

Clínico — náuseas y/o vómitos de intensidad suficientemente alta. Se deben excluir otras causas (digestivas, neurológicas, etc.).

Tratamiento Escalonado

TABLA 3.4.1: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Náuseas leves / embarazo normal	Educación, sin fármacos — se resuelve sola en semanas
Náuseas predominantes, sin vómitos significativos	Vitamina B6 (piridoxina) ± jengibre
Vómitos abundantes (hiperemesis propiamente tal)	Doxilamina (antihistamínico, 1ª elección) + Vitamina B6
Segunda línea	Metoclopramida
Tercera línea	Ondansetrón

Complicación: Deshidratación Severa

- Si la paciente llega deshidratada:
- Hidratación parenteral (suero endovenoso)
 - Tiamina (Vitamina B1) — prevención de **encefalopatía de Wernicke**
 - Aporte de oligoelementos

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Tiamina en hiperemesis: No es solo para alcohólicos. Una embarazada con vómitos severos y deshidratación tiene riesgo de encefalopatía de Wernicke → siempre agregar tiamina EV junto con la hidratación.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Hiperemesis Gravídica: Ocurre en la primera mitad del embarazo (peak en semanas 8–12, cuando la HCG es ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hiperemesis Gravídica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico
- Tratamiento Escalonado
- Complicación: Deshidratación Severa
- Gonadotropina coriónica humana (HCG)
- primera mitad del embarazo
- de los síntomas. ::: --- ## Diagnóstico
- Náuseas leves / embarazo normal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPEREMESIS GRAVÍDICA)**PREGUNTA 1**

En relación a Hiperemesis Gravídica: Ocurre en la primera mitad del embarazo (peak en semanas 8–12, cuando la HCG es ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Hiperemesis Gravídica se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Hiperemesis Gravídica debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Hiperemesis Gravídica requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Hiperemesis Gravídica es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Hiperemesis Gravídica no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Hiperemesis Gravídica?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Hiperemesis Gravídica. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: HIPEREMESIS GRAVÍDICA

Gonadotropina coriónica humana (HCG) — principal. Los estrógenos también participan, pero la HCG es lo más importante. :::note Es normal que toda embarazada tenga algún grado de náuseas. La hiperemesis gravídica se distingue por la severidad de los síntomas. ::: Clínico — náuseas y/o vómitos de intensidad suficientemente alta. Se deben excluir otras causas (digestivas, neurológicas, etc.).